Der Verordnungs-Check

KI-gestützte Prüfung von Heilmittelverordnungen · Statusmeldung an MSIT

Thomas · Valentin · Derk | Stand 19.10.2026

Scope: ein Prüfschritt, bevor behandelt wird

Was das System leistet

Problem	Fehlerhafte Verordnungen fallen erst bei der Abrechnung auf. Die Leistung ist erbracht, die Kasse kürzt oder setzt ab.
Für wen	Rezeption einer Physiotherapie-Praxis (anonymisiert), ca. 40 neue Kassenverordnungen pro Woche
Was	Prüft eine GKV-Verordnung (Muster 13) gegen Heilmittel-Richtlinie, Heilmittelkatalog und KBV-Diagnoseliste: Ampel, Korrekturhinweis, Fundstelle
Ziel	≥ 98 % richtige Ampeln bei ≥ 50 ungesehenen Testverordnungen, keine rote übersehen

Ausdrücklich nicht

- ✗ Keine automatische Ablehnung – die Rezeption entscheidet
- ✗ Keine Anbindung an die Praxissoftware
- ✗ Keine Abrechnung
- ✗ Nur Physiotherapie, nur GKV
- ✗ Keine medizinische Beurteilung
- ✗ Keine echten Patientendaten

Rollen im Team: seit 19.10. zu dritt



Thomas

Koordination

- Ist/Soll-Analyse und Field Study
- Einsatzfelder
- Business Case
- Roter Faden der Präsentation



Valentin

Tools, Architektur & Governance

- Tool-Vergleich und Tool-Auswahl
- Architektur und Trade-offs
- EU AI Act, DSGVO
- IHK-Deck



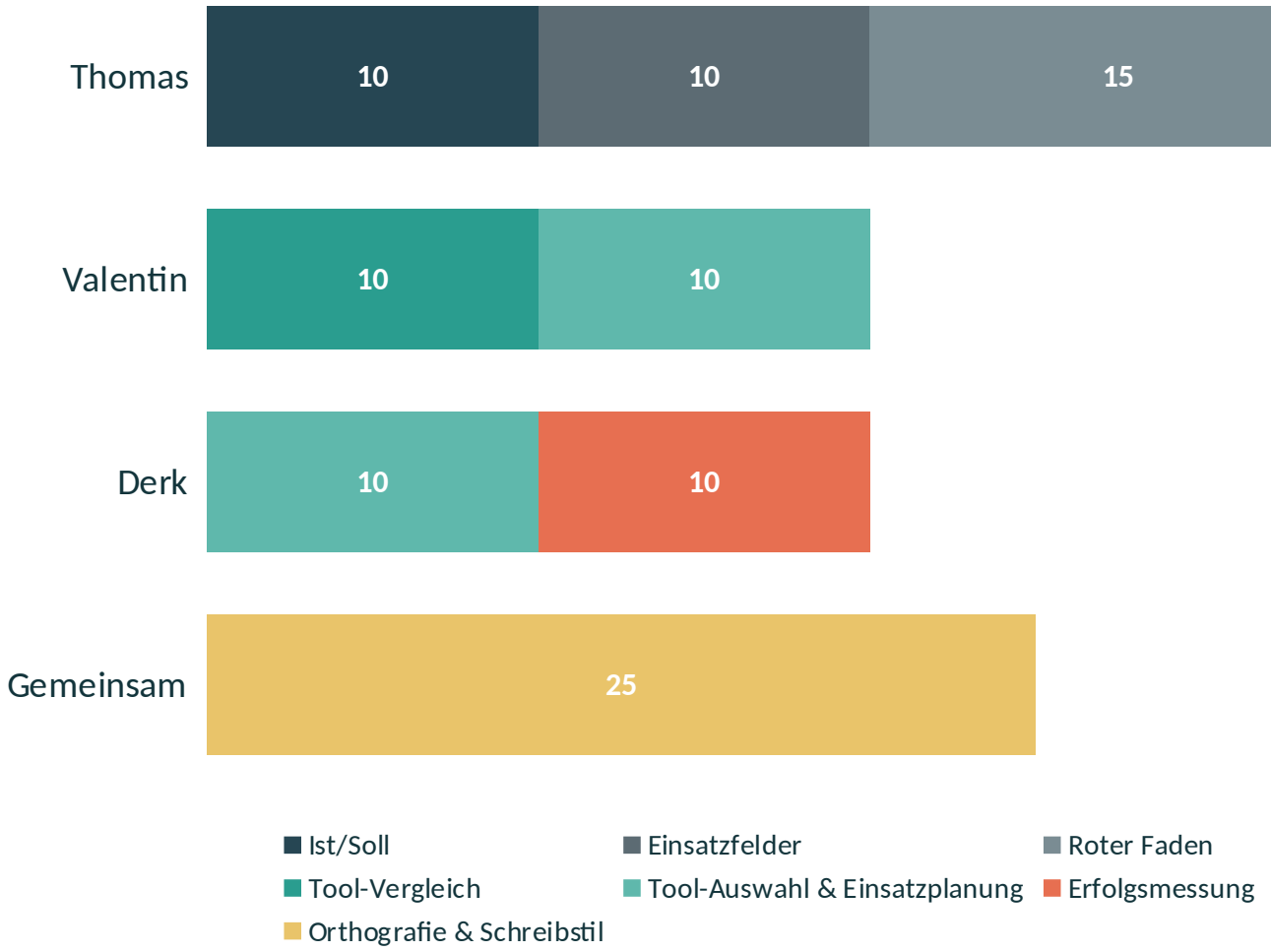
Derk

Build, Demo & Evaluation

- n8n-Workflow und Supabase
- Verordnungsfall-Prüfung (v5)
- Evaluation mit 50 Testfällen
- Einsatzplanung und Pilot

Gemeinsam: Orthografie und Schreibstil im Vier-Augen-Prinzip. Jede Person präsentiert in der IHK-Prüfung einen eigenen Block.

IHK-Bewertung: wer welche Punkte verantwortet



Punkte je Person

Thomas	35
Valentin	20
Derk	20
Gemeinsam	25

Inhalt 60 + Form 40 = 100 Punkte.
Redezeit ca. 15 min je Person.

Architektur: Regeln rechnet der Code, Sprache das Modell

Chat

Rezeption gibt die Verordnung ein

Erfassen

LLM überführt Text in festes Schema

Fakten

Code: Fristen, Formate, ICD → Diagnosegruppe

4 Prüfer

Formal · Diagnose · Mengen · Fristen

Ampel

Code: rot / gelb / grün, Absetzungsrisiko

RAG

Supabase

- Wissensbasis (RAG): HeilM-RL, Heilmittelkatalog, KBV-Diagnoseliste, rund 380 Abschnitte
- Protokoll jeder Prüfung und jedes Befunds
- Neu in Sprint 2: Verordnungshistorie für die Verordnungsfall-Prüfung

Stack

- n8n Cloud (Workflow, Chat)
- OpenAI gpt-4.1-mini
- Supabase (pgvector, EU)
- GitHub: Exporte, Tests, Doku

Field Study: Ist-Interview mit der Praxis (16.10.)

90 %

der Fehler entstehen bei Doppel- und Folgeverordnungen

40

neue Kassenverordnungen pro Woche

8 min

Prüfung je Verordnung (6 bei Annahme + 2 vor Abrechnung) = ca. 5,3 Std./Woche

32 €

Vergütung je Einheit im Schnitt (bisherige Annahme 28 €)

Was daraus folgt

- Verordnungsfall-Prüfung bestätigt als Priorität (Sprint 2)
- Doppelverordnungs-Prüfung wird als nächster Kandidat bewertet
- Business Case: Hebel sind Prüfzeit und Qualität. Absetzungen nur ca. 500 € pro Jahr, den Rest fängt ein Abrechnungsdienstleister ab (3–6 % vom Umsatz)
- Pilot: Parallelbetrieb zugesagt
- Ziel 98 %: menschliche Doppelkontrolle ist laut Praxis höchstens ca. 85 % wirksam

Stand und nächste Schritte

10/10

Ampeln korrekt im Prototyp (v4)

0

kritische Fehlalarme (Start: 12)

24 s

je Prüfung, ca. 3–4 Cent

bis 16.10.	**Sprint 1** ✓	Design-Briefing im Repo: Scope, Erfolgskriterien, Architektur, Build-Plan
19.–23.10.	**Sprint 2**	Workflow v5 mit Verordnungsfall-Prüfung, Business Case (erste Fassung)
26.–30.10.	**Sprint 3**	Formale Evaluation: ≥ 50 neue Fälle, je 3 Läufe, Ziel ≥ 98 %. Governance, IHK-Deck-Entwurf
03.11.	**MSIT-Prüfung**	Empfehlung zur IHK-Zulassung
05.11.	**IHK-Prüfung**	Präsentation und Fachdiskussion

Repository: github.com/thomaskullmann-wq/verordnungs-check